

THRESHOLD

THRESHOLD

**За восемь недель находит, какая еда
вызывает симптомы — по клиническому
протоколу, а не по советам.**

Первый протокол из библиотеки. Дальше —
сон, давление, нагрузка.

Протокол, который работает, существует. Вести по нему некому

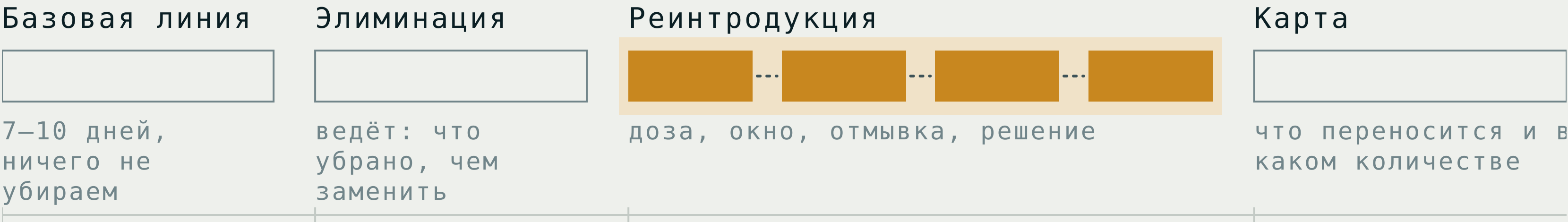
- 15–25 млн взрослых в США. Симптомы годами
- Гуглят, убирают наугад, бросают дневник
- Гайдлайн ACG: диета сложна, нужен подготовленный диетолог
- Диетологов на эту аудиторию не хватает
- Кто начал — застревает на элиминации

Даже с диетологом до конца доходят четверо из десяти

- Все выпустили «протоколы» — это план, а не ведение. Данные лежат и ждут
- Клиническое исследование низко-FODMAP программы: 41% доходят до шестой недели — **с** диетологом, без ежедневного ведения
- Это провал не мотивации, а конструкции. Никто не говорит человеку, какой сегодня день и что делать дальше
- Threshold ведёт день за днём — не хранит данные, а доводит до результата

THRESHOLD

Приложение знает, какой у вас сегодня день протокола



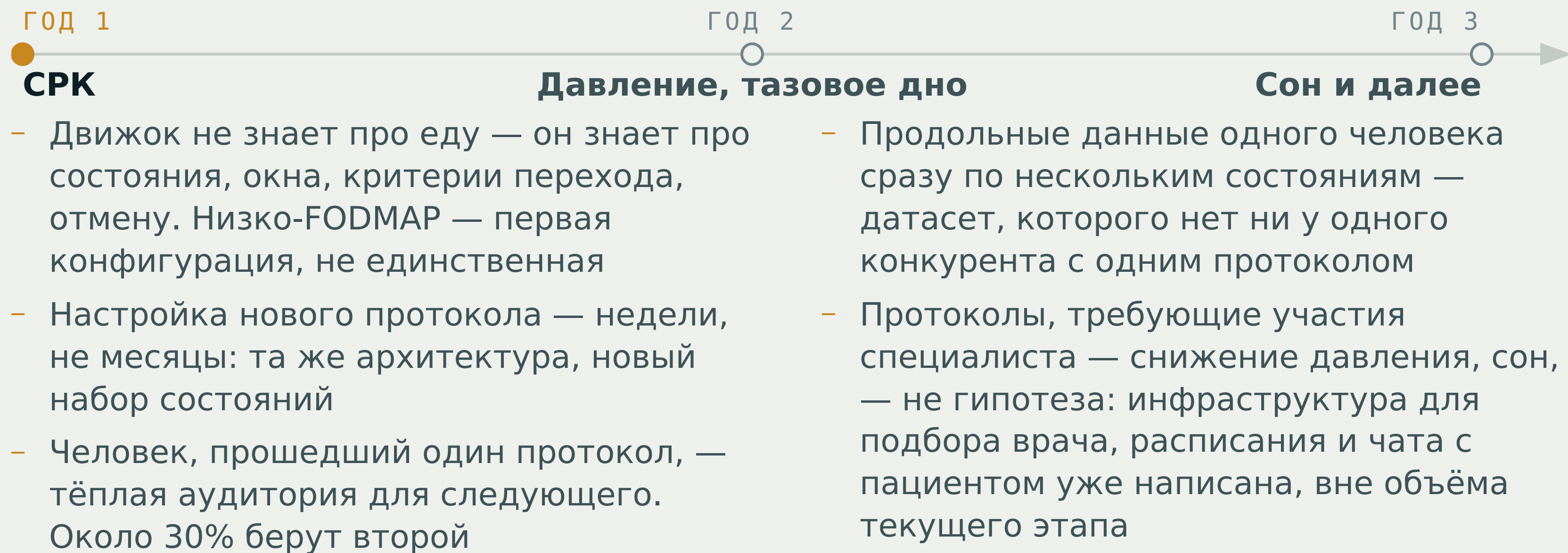
Правило перехода арифметическое. Протокол умеет закончиться выводом «не помогло».

Два года назад это было нельзя построить. Через год позицию займут

- Разложить блюдо на группы стало дешевле
- Голосовой ввод дошёл до нужного качества
- Рынок приучен к ИИ в здоровье — не нами
- Позиция названа, но не занята

Мы это уже построили. Соберём заново — по спецификации

- Команда несколько лет вместе. Система работает в клинике
- Пройдено: интеграция с Apple Health и Google Health, распознавание выписок, голосовой ввод, память фактов, журнал питания, корреляции, данные структурированы по FHIR
- Движок разворачивает протокол настройкой, а не разработкой
- Пересборка с нуля по функциональной спецификации. Юридическая проверка чистоты — до начала работ



Телемедицинский модуль — вне скоупа MVP и текущего ask, упоминается как задел под следующие протоколы.
Права и условия использования — предмет отдельного разговора, не этой сделки

Протокол конечен. Продаём не подписку, а очередь протоколов

- Программа — \$179. Восемь недель, карта переносимости, выписка врачу
- Годовой план поддержания — \$149, оплата в момент завершения протокола
- Следующий протокол — снова программа, \$149
- Ключевая метрика: доля перешедших ко второму протоколу
- Позже — тариф со специалистом

THRESHOLD

**\$179 приносит \$155 маржи. Дальше
решает цена привлечения**

\$155

МАРЖА С ПРОГРАММЫ

\$188—249

ПОЖИЗНЕННАЯ ЦЕННОСТЬ

\$150

ПОТОЛОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ

- Себестоимость \$12 из \$179 — 93% валовой маржи
- Пожизненная ценность одного пользователя: \$188–249 в зависимости от того, сколько доходит до конца
- Работает при стоимости привлечения до \$150. Уверенно работает при \$75 и ниже
- Смоук-тест — единственный способ узнать, где мы окажемся

THRESHOLD

Инструменты для записи есть. Очередь никто не ведёт

ИЗМЕРЯЮТ	Function, Whoop, Oura — план, а не ведение
КУРС ИЛИ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	Nerva; Monash — Step 2, дозы, лесенка
ВЕДУТ	Salvo \$127/мес и Sleep Reset — на живых людях
ПРОГРАММНО	только Stellar Sleep, один протокол
ПУСТО	несколько протоколов подряд в одной подписке

Не строим, пока не проверим, дешевле ли \$75-150 привести человека

- Лендинг с реальной оплатой. Тест цены: программа \$179 против подписки
- Порог объявлен заранее, не подгоняется под результат
- 12 интервью проведены, страница готова
- Дальше: 8 недель сборки, октябрь — стенд с платящими

Четыре риска и механизм по каждому

РАССТРОЙСТВА
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

В клинической когорте 23% с риском РПП, и приверженность диете у них **выше**, чем у остальных: 57% против 35%. Метрика роста и главный риск причинения вреда смотрят в одну сторону. Скрининг на входе, правило остановки внутри протокола, отказ обслуживать при срабатывании — в первой версии, не во второй

РЕГУЛЯТОРНЫЙ

Наблюдения, а не утверждения; разбор формулировок под FDA и FTC до включения трафика; юрист до релиза

ПЛАТЯТ ЛИ

Смоук-тест с порогом по стоимости привлечения до разработки

ЛИЦЕНЗИИ НА ШКАЛЫ

В первой версии собственные инструменты

Покупатель платит за данные и канал, не за выручку одного протокола

- Фарма с гастро-портфелем, консолидаторы цифровой терапии, потребительское здоровье
- Им нужны продольные данные по подгруппам и канал к пациентам, которых у них нет
- Библиотека протоколов — то, что превращает разовый продукт в датасет и канал

THRESHOLD

\$165k, два этапа фиксированной ценой

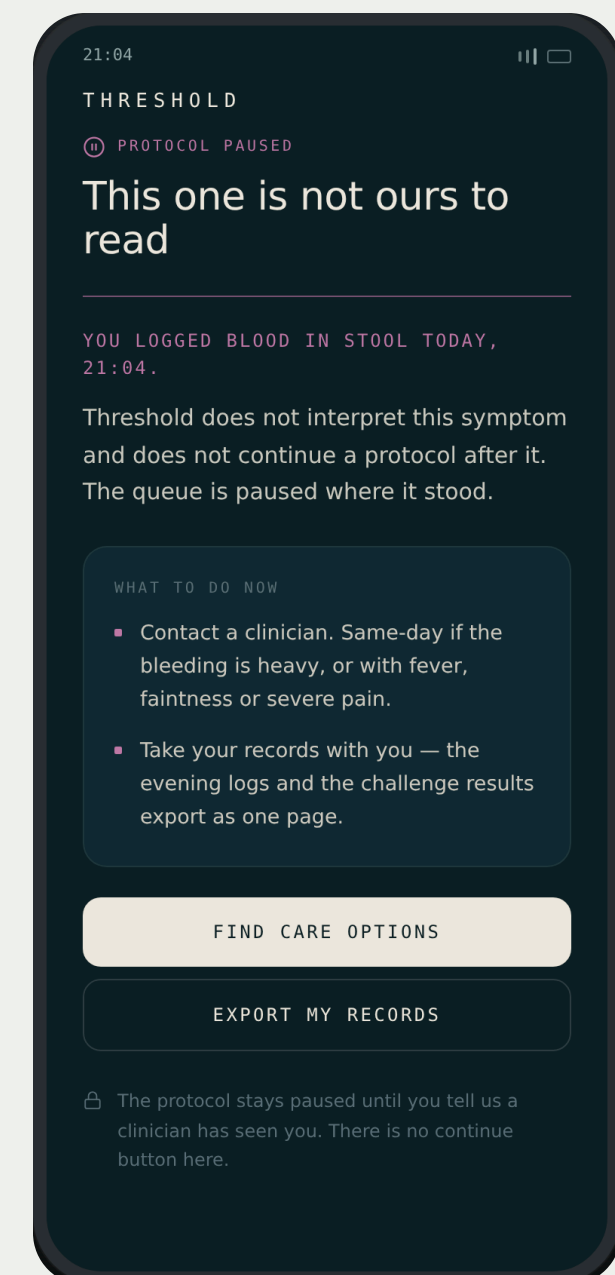
- Смоук-тест — \$25 000. Ответ: дешевле ли \$75–150 привести платящего человека
- MVP — \$140 000, фиксированная цена, 8 недель. Полная сборка, юридический пакет
- Оба этапа — фиксированная цена. Оплата за результат, не почасовая
- Дальше — контракт на ведение с минимальным сроком, отдельно от этого запроса

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Красные флаги и критерии исключения протокола

Протокол останавливается сам и не предлагает обходного пути: кровь в стуле, непреднамеренная потеря веса, симптомы, будящие ночью, дебют после пятидесяти.

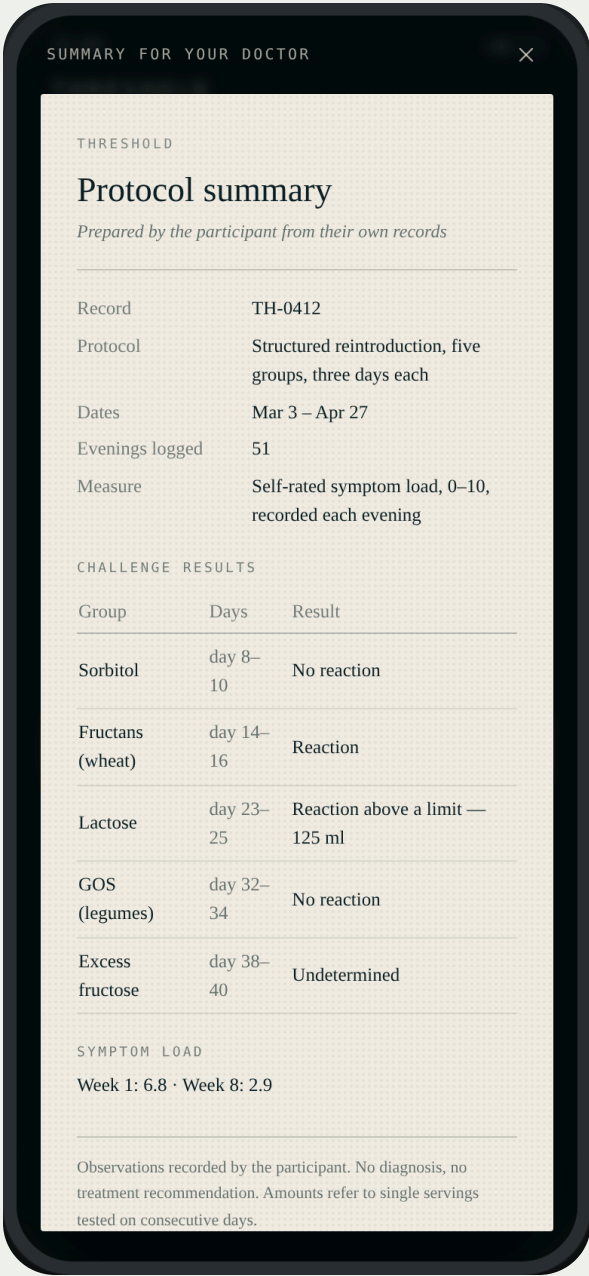
Экран не интерпретирует симптом и не ставит диагноз — он останавливает очередь и отправляет к врачу.



Экран прототипа с выпиской для врача

Одна страница: протокол, даты, результаты челленджей по группам и динамика симптомов в тех же единицах, что человек отмечал каждый вечер.

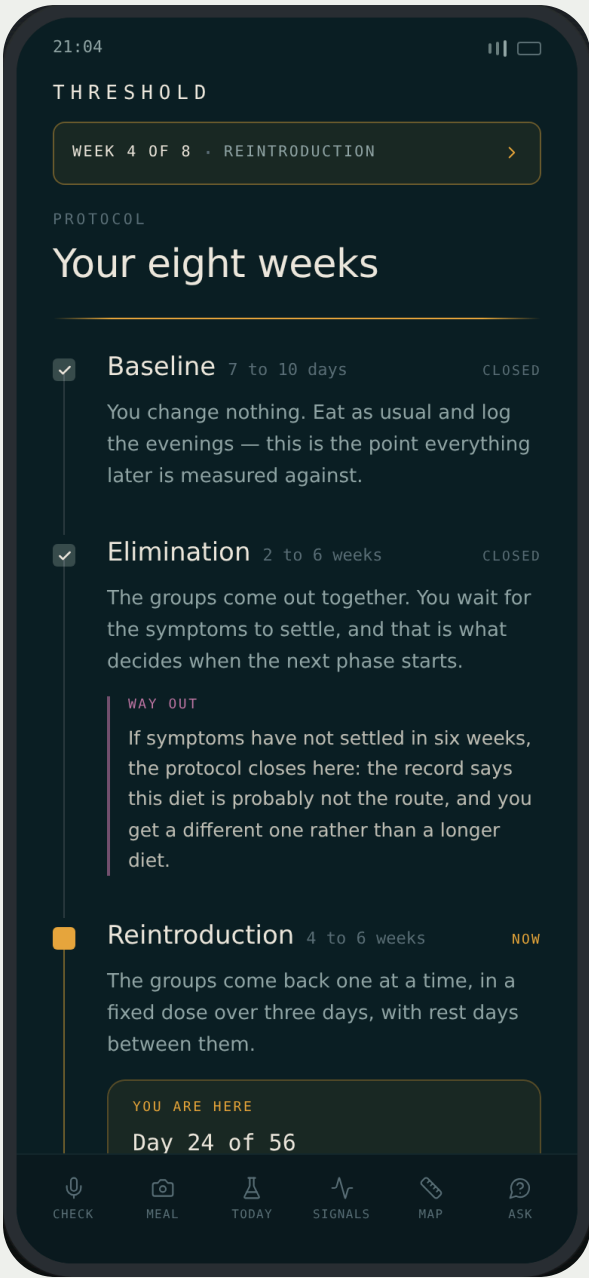
Внизу — строка о том, что это наблюдения участника, а не диагноз и не назначение.



Экран прототипа: восемь недель протокола

Четыре фазы с границами, текущая позиция днём из пятидесяти шести и правило выхода: если за шесть недель симптомы не осели, протокол закрывается здесь, а не продлевается.

Прогноз дан диапазоном — «4–6 недель», а не датой, потому что переход к следующей фазе решают симптомы, а не календарь.



Экран прототипа: день челленджа и искажающий фактор

Доза на сегодня, лестница из трёх дней и одна еда на весь челлендж — это и есть ведение, которого нет в дневниках.

Первый день помечен как не засчитанный: четыре часа пятьдесят минут сна накануне, и разделить дозу и ночь по этому дню нельзя. Предложено повторить группу.

